



Trastorno neurocognitivo leve

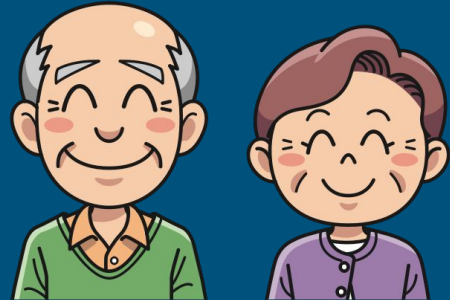


Melissa Torres



Envejecimiento normal

- cambios biológicos: disminución en la estatura y peso corporal, cambios en los compartimentos corporales, **modificaciones en el Sistema Nervioso Central**: cambios en el peso y volumen cerebral, cambios en la neurotransmisión, aumento en el tamaño de los ventrículos y depósitos de Beta amiloide
- funcionamiento a nivel cognitivo empieza a declinar de la misma manera:
 - Enlentecimiento
 - Inhibición de información poco relevante
 - Deterioro en memoria episódica (disminución en la velocidad del procesamiento de estímulos y fallas en el procesamiento contextual de la información, así como reducción de acceso a los detalles específicos del contexto, que puede resultar en una Codificación poco exitosa de la información)
 - Lenguaje suele estar preservado



→ Alteración cognitiva. Cualquier queja cognitiva en la que no existe evidencia de demencia ni de síndrome confusional, reportada por un informador fiable y no constatada mediante tests psicométricos.

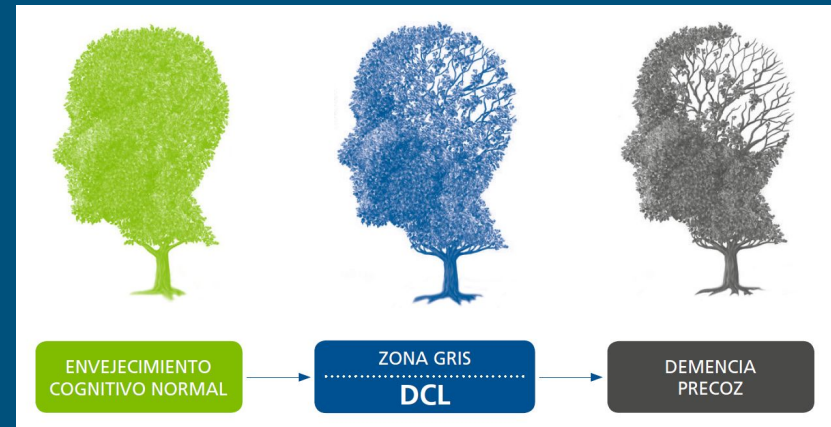
«deterioro» señala que es adquirido, y que aparece en una persona con funciones cognitivas conservadas previamente o con un empeoramiento de dichas funciones con respecto a un nivel previo superior.

→ Deterioro cognitivo leve. Además de lo incluido en la alteración cognitiva se aprecia un rendimiento anómalo en algún área cognitiva mediante pruebas psicométricas.

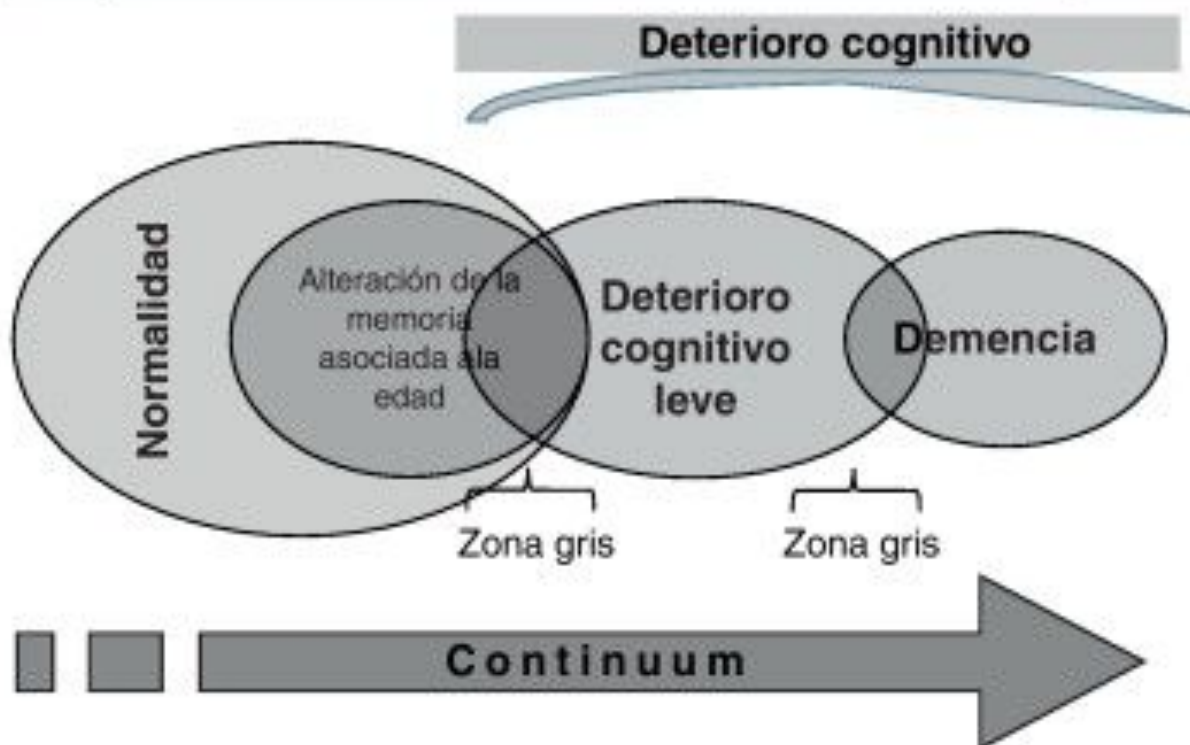


DCL

- Concepto se introduce en 1980s por una necesidad de explicar aquellos pacientes que no estaban en un envejecimiento normal ni en una demencia
- Petersen et al. en 1999 desarrolló el concepto basándose en un estudio observacional sobre el envejecimiento, estudio que se planteó para generar conciencia clínica de esa 'zona gris' de deterioro cognitivo existente que no se podía clasificar ni como EN ni DEM
- Necesidad de algo más allá de esa clasificación dicotómica de presencia o ausencia de demencia que podría ayudar a un diagnóstico temprano y prevención con tratamientos en etapas tempranas



Solapamiento en el "Continuum" de rendimiento cognitivo



Evolución del concepto DCL

1990s Mayo Clinic

Estudio para caracterizar envejecimiento normal y demencia en el cual encontraron un grupo importante que no se podía clasificar y así introducen el término DCL para explicar este grupo

Ésta primera definición estaba enfocada en los problemas de memoria considerados como un pródromo de EA

La comprensión de que otras causas podrían llevar a MCI llevó a la necesidad de expandir el concepto



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

Evolución del concepto DCL

2003 - Conferencia internacional para llegar a un consenso del concepto

El enfoque ya no sólo iba a estar en los déficits en la memoria

Fue ampliado para considerar déficits también en las otras áreas cognitivas

DSM V

Reconoce el estado de pre demencia de déficits cognitivos

Se determina como Trastorno Cognitivo Menor pero representa las mismas características del DCL

Table 1

Clinical characterization of mild cognitive impairment (MCI)

Definitions	Original Mayo Clinic [6]	Expanded/Key Symposium [7, 8]	NIA-AA [16]	DSM-5 [15]
Criteria				
<i>Self- or informant-reported memory complaint</i>	x			
<i>Self- or informant-reported cognitive complaint</i>		x	x	x
<i>Objective memory impairment</i>	x			
<i>Objective cognitive impairment</i>		x	x	x
<i>Essentially preserved general cognitive functioning</i>	x			
<i>Preserved independence in functional abilities</i>	x	x	x	x
<i>No dementia</i>	x	x	x	x

Core clinical criteria according to major definitions are listed.

NIA-AA, National Institute on Aging-Alzheimers Association workgroup; DSM-V, fifth edition of the *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*; X: criterion required..

Quejas subjetivas

- Subjetivo hace referencia a la propia percepción del funcionamiento cognitivo y es independiente al desempeño en una prueba cognitiva
- Las quejas subjetivas de los cambios en el funcionamiento cognitivo son consideradas un criterio esencial de la definición del DCL y el pródromo de EA
- Esta experiencia subjetiva sobre la disminución del funcionamiento cognitivo, aún estando en una etapa en donde no se observan estas fallas en las pruebas cognitivas, se ha asociado con un incremento en biomarcadores anormales consistentes con la patología de la EA y un incremento en el riesgo de un futuro deterioro mayor y una EA.
- QS se vuelven un indicador clínico sintomático que representa un factor de riesgo para desarrollar un DCL o una EA
- Por esta razón, la queja subjetiva se vuelve un elemento muy importante para un posible diagnóstico temprano e intervenciones preventivas



Quejas subjetivas

Importante a tener en cuenta:

Hay evidencia que demuestra que el reporte brindado por el informante puede ser un mejor predictor del funcionamiento objetivo del paciente que su propio reporte

Este reporte puede ayudar y facilitar la identificación de un deterioro que se pueda posiblemente relacionar con una EA

Muchos cuadros psiquiátricos también están asociados con una queja subjetiva de deterioro cognitivo



Cuadros psiquiátricos mayores deberían ser un criterio de exclusión a considerar un posible DCL ya que no debe haber presencia de otra cosa que pueda claramente afectar la percepción subjetiva de la capacidad cognitiva el paciente

DCL - DSM V

El DSM-5 engloba el término trastorno neurocognitivo menor y mayor. El término de demencia queda sustituido por el término trastorno neurocognitivo mayor,

Su desaparición consolida, además, el criterio de continuidad o evolución del concepto de deterioro cognitivo, al aumentarse la gravedad e intensidad de las manifestaciones Clínicas.

El término DCL queda englobado en el DSM-5 como trastorno neurocognitivo menor

Engloba el deterioro producido por cualquier etiología y rango de edad, tales como un traumatismo craneoencefálico o el deterioro producido debido a cuadros epilépticos.



Criterios diagnósticos DCL

1. Alteración de una o más de las siguientes áreas cognitivas:
 - a) Atención-concentración.
 - b) Lenguaje.
 - c) Gnosias.
 - d) Memoria.
 - e) Praxias.
 - f) Funciones visuoespaciales.
 - g) Funciones ejecutivas.
2. Esta alteración debe ser:
 - a) Adquirida, señalando un deterioro respecto a las capacidades previas.
 - b) Referida por paciente o informador fiable.
 - c) Objetivada en exploración neuropsicológica.
 - d) De meses de duración y constatada por paciente con nivel de conciencia normal.
3. La alteración cognitiva sólo interfiere mínimamente en las actividades instrumentales o avanzadas de la vida diaria.
4. La alteración cognitiva no se asocia a deterioro del nivel de conciencia.



Figura 2 – Propuestas conceptuales de la quinta edición del *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales*, desde la cognición normal al trastorno neurocognitivo mayor severo.

DCL - Tipos

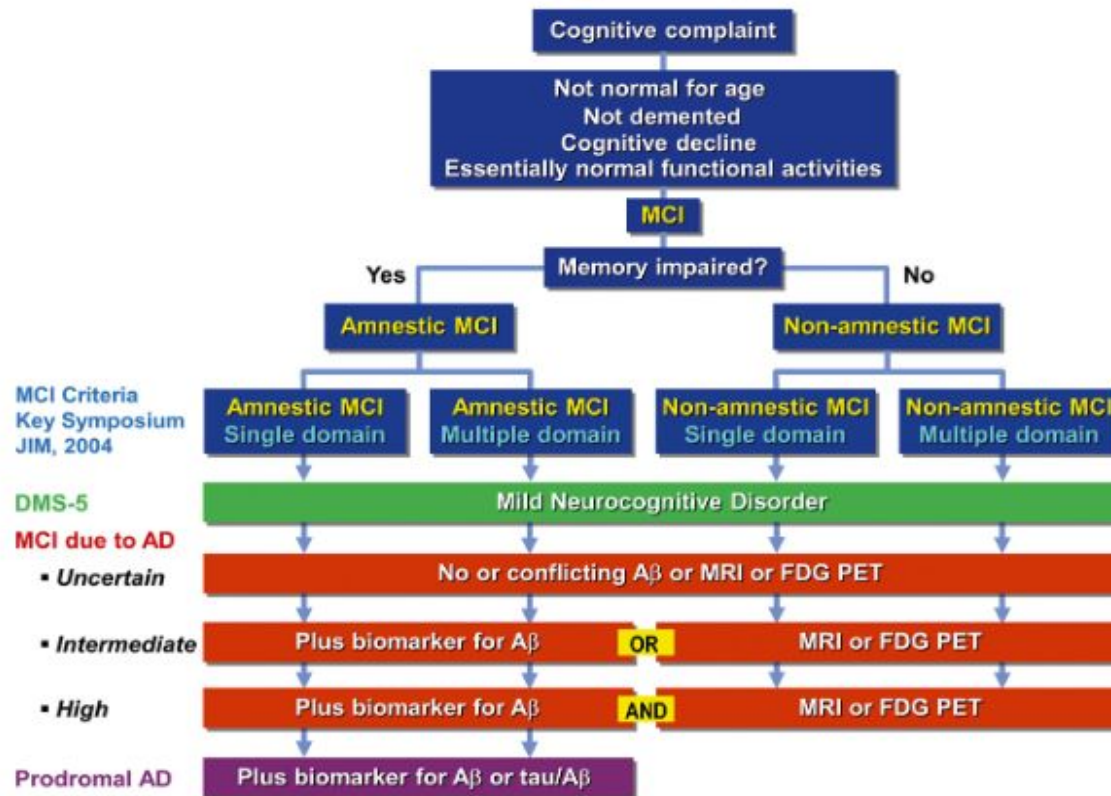
2004

Una ampliación del término identificando 4 subtipos de DCL

TIPOS:

- Deterioro Cognitivo Leve de tipo Amnésico (DCLa)
 - Un dominio: memoria.
 - Multidominio: memoria más otra habilidad cognitiva
- Deterioro Cognitivo Leve de tipo No Amnésico
 - Un dominio: habilidad cognitiva distinta a memoria
 - Multidominio: al menos dos habilidades cognitivas distintas a memoria.

Mild Cognitive Impairment



Quejas subjetivas de memoria

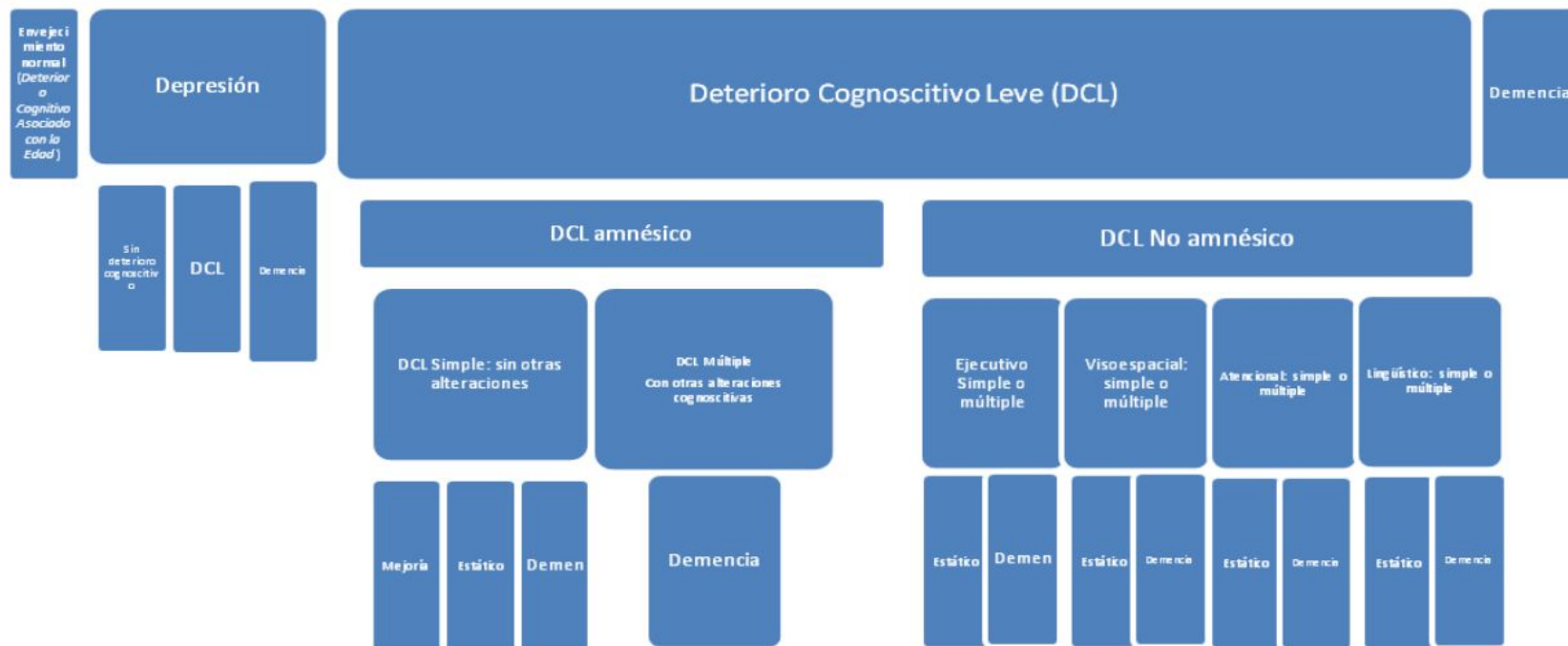


Figura 1. Esquema de los posibles diagnósticos originados con el perfil neuropsicológico partiendo de las quejas subjetivas de memoria (tomado de Rosselli & Ardila, 2010).

FACTORES PROTECTORES

